Fiebre reumática

FISIOPATOLOGIA · Clase 10 · de una faringitis a una válvula que se deforma años después

1 · QUÉ ES Y POR QUÉ SOLO ALGUNOS LA DESARROLLAN

Fiebre reumática
enfermedad inflamatoria difusa no supurativa del tejido conjuntivo; complicación tardía (2-3 semanas) de una faringitis

es causada por el

F1
Estreptococo beta hemolítico del grupo A
agente de la faringoamigdalitis; la bacteria no daña el corazón, lo hace la respuesta inmune

en la faringe produce la

Faringoamigdalitis previa
fiebre, cefalea, náuseas, adenopatías y dolor abdominal; la fiebre reumática llega 2-3 semanas después

en la piel produce, en cambio,

F3
Impétigo (piel)
el mismo estreptococo en la piel lleva a glomerulonefritis aguda, no a fiebre reumática

2-3 semanas después, en el

F2
Hospedero susceptible
solo el 3 % de los infectados; predisposición familiar; 5-15 años; invierno, altura y pobreza

desencadena una

2 · CÓMO LA DEFENSA ATACA AL PROPIO CUERPO

Reacción autoinmune cruzada
los antígenos del estreptococo se parecen a los del corazón, articulaciones, piel y ganglios basales: se forman anticuerpos y células T contra ellos

en las articulaciones causa

en el miocardio forma el

F7
Cuerpo de Aschoff
necrosis rodeada de células inmunes en el miocardio; lesión típica de la fase aguda

marca la

Fase aguda
antecedente estreptocócico más compromiso de corazón, SNC, articulaciones y tejido subcutáneo

es criterio mayor de

3 · POLIARTRITIS: LA QUE SALTA Y CURA

F4
Poliartritis migratoria
manifestación más frecuente (75 %) y primer síntoma; articulaciones grandes (rodilla, tobillo)

salta de articulación en el

cuenta como criterio

F11
Dolor que salta
dura cerca de 1 semana en cada articulación y pasa a otra; si persiste más, pensar en otra causa

cede con aspirina y

F11
Cede con aspirina en 48 h (antiinflamatorios) y **cura sin secuelas**

4 · CARDITIS: LA QUE DEJA SECUELA

en el corazón causa

F4
Carditis
inflama endocardio, miocardio y pericardio; la causa de las secuelas permanentes

en el endocardio produce

Endocardio: valvulitis
en la fase aguda da insuficiencia mitral (más común) o aórtica, con soplo apical

si llega a la conducción alarga el

F6
ECG
bloqueo AV de primer grado: PR > 0,20 s; también cardiomegalia y cambios inespecíficos del ST-T

en el miocardio y pericardio da

Miocardio y pericardio
taquicardia desproporcionada a la fiebre, galope e insuficiencia cardiaca; pericarditis con dolor y roce

casi siempre aparece con la

en el tejido subcutáneo forma

5 · COREA, NÓDULOS Y ERITEMA MARGINADO

en los ganglios basales causa

F5
Nódulos subcutáneos
0,5-2 cm en codos, rodillas y tobillos; casi siempre con carditis moderada o grave

F5
Eritema marginado
máculas rosadas sin picazón, borde serpiginoso y centro pálido en tronco y raíz de miembros; no afecta la cara

en la piel produce el

F12
Corea de Sydenham
anticuerpos contra los ganglios basales: movimientos rápidos, espontáneos y sin propósito

suele presentarse como

Perfil de la corea
niñas de 8-15 años, semanas o meses después de la infección; puede ser la única manifestación

es criterio mayor de

si hay recurrencias pasa a la

es criterio mayor de

6 · DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

F6
Criterios menores
fiebre, artralgia, leucocitosis, PCR y VSG elevadas, PR > 0,20 s y fiebre reumática previa

se suma a los mayores en los

F5
Criterios de Jones
2 mayores, o 1 mayor + 2 menores, con evidencia de infección estreptocócica previa

al confirmarse indica

se aplica, por ejemplo, en el

F10
Caso
niña de 10 años, faringitis hace 3 semanas, dolor migratorio en rodillas y tobillos y soplo apical nuevo, VSG y PCR altas: 2 mayores = fiebre reumática aguda

F9
Penicilina por 10 días completos
erradica el estreptococo aunque haya mejoría antes; macrólidos si hay alergia

si es completa logra la

se complementa con

Profilaxis prolongada
antibiótico a largo plazo tras una carditis para evitar recurrencias

Con tratamiento adecuado: cura sin secuelas valvulares

al repararse deja

7 · EVOLUCIÓN: DE LA FASE AGUDA A LA VÁLVULA DEFORMADA

Fase recurrente
las recidivas extienden los defectos cardiacos y la deformidad valvular; son más comunes en los primeros 5 años

F13
Fibrosis retráctil
la inflamación se repara con cicatriz que acorta las cuerdas y fusiona las comisuras

empeora y progresa a la

produce la deformidad de la

Fase crónica
deformidad permanente de la válvula; los síntomas pueden aparecer hasta 10 años después del ataque

afecta sobre todo a la

previene las recidivas de la fase

F8
Compromiso valvular
mitral 75-85 %, aórtica 30 %, tricúspide 7 %, pulmonar 3 %

con los años conduce a

en lo grave termina en

Insuficiencia cardiaca; a veces cirugía de reemplazo valvular y menor expectativa de vida

concepto · causa · ejemplo · mecanismo · signo · desenlace · diagnóstico · complicación · borde dorado = alto rendimiento · F# = pregunta n.º # de la lámina

Fuente: Clase 12 · Dr. Sotito — teoría del docente (= literatura)